

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Tatielle Rodrigues Teixeira

16.0 / 20

APROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	2.0	Bom (100%)
2	2.0	2.0	Bom (100%)
3A	2.0	1.5	Parcial (75%)
3B	2.0	1.5	Parcial (75%)
3C	2.0	1.0	Insuf. (50%)
4	2.0	2.0	Bom (100%)
5	2.0	1.5	Parcial (75%)
6	2.0	1.5	Parcial (75%)
7	2.0	1.5	Parcial (75%)
8	2.0	1.5	Parcial (75%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: **2.0** / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Nucleo definido e organelas complexas (eucariotico)
- Nao produzem proprio alimento, dependem de absorcao (heterotrofico)
- Semelhanca com celulas humanas dificulta tratamento
- Poucos alvos terapeuticos seletivos

Feedback: Resposta completa e bem articulada. Abordou tanto a classificacao quanto o impacto na patogenicidade, destacando a dificuldade terapeutica pela semelhanca celular.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Principal esterol da membrana citoplasmatica
- Mantem integridade, fluidez e funcao da membrana
- Polienicos ligam-se a ele, azois inibem sua sintese
- Celulas humanas possuem colesterol - seletividade

Feedback: Excelente resposta. Cobriu todos os elementos: papel do ergosterol, mecanismos dos antifungicos e a base da seletividade terapeutica.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Unicelulares
- Formato oval ou esferico
- Reproducao por brotamento (gemulacao)

O que faltou:

- Formacao de pseudohifas em algumas especies

Feedback: Resposta correta e concisa com os elementos principais. Faltou mencionar a capacidade de formar pseudohifas, caracteristica importante de algumas especies como *Candida albicans*.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Conjunto de hifas (filamentos)
- Base estrutural dos fungos filamentosos
- Absorcao de nutrientes e secrecao de enzimas

O que faltou:

- Hifas septadas ou cenocíticas
- Organizacao em micelio vegetativo e aereo/reprodutivo

Feedback: Definiu corretamente micelio e sua funcao. Faltou detalhar os tipos de hifas e a organizacao em micelio vegetativo versus reprodutivo.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Capacidade de crescer em duas formas (levedura ou filamento)
- Estrategia de adaptacao para invasao

O que faltou:

- Relacao com temperatura (25C filamentosa, 37C leveduriforme)
- Evasao do sistema imune especificamente
- Dificuldade diagnostica (formas diferentes em cultura vs tecido)

Feedback: Definiu dimorfismo corretamente mas de forma muito superficial. Faltou a relacao com temperatura, mecanismos de evasao imune e impacto no diagnostico laboratorial.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Agente ceratolítico/alcalino
- Dissolve queratina e restos celulares
- Estruturas fungicas resistentes a digestao alcalina
- Permite visualizacao ao microscopio para diagnostico rapido

Feedback: Resposta excelente e completa. Mencionou o principio ceratolítico, a dissolucao de queratina, a resistencia fungica a digestao alcalina e a finalidade diagnostica.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Nao invadem tecidos vivos
- Sem resposta inflamatoria significativa
- Dano predominantemente estetico

O que faltou:

- Localizacao especifica (camada cornea, pelos, unhas)
- Exemplos (pitiríase versicolor, piedra)

Feedback: Identificou corretamente ausencia de invasao, falta de inflamacao e carater estetico. Faltou especificar as estruturas afetadas e dar exemplos clinicos.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitiríase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Superficiais apenas na parte externa da queratina sem resposta imune
- Cutaneas mais profundas na epiderme
- Cutaneas causam destruicao de queratina e reacoes inflamatorias

O que faltou:

- Agentes etiológicos (dermatofitos: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton)
- Sintomas específicos (prurido, descamação, lesões ativas)

Feedback: Boa diferenciacao com mencao a profundidade, resposta imune e destruicao de queratina. Faltou citar os agentes etiológicos e sintomas clinicos específicos.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como *Malassezia* e *Piedraia*, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (*Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Fazem parte da microbiota normal
- So causam infeccao com condicoes favoraveis no hospedeiro
- Queda de imunidade e desequilibrio da flora por antibioticos

O que faltou:

- Equilibrio com hospedeiro em condicoes normais explicitado
- Outros fatores: dispositivos invasivos, diabetes

Feedback: Boa resposta mencionando microbiota normal, oportunismo e fatores como imunossupressao e antibioticos. Poderia ter detalhado mais fatores de risco e o conceito de equilibrio.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Pode representar colonizacao ou contaminacao
- Colonizacao: fungo presente sem causar dano
- Contaminacao: introducao accidental durante coleta ou processamento

O que faltou:

- Necessidade de correlacao clinica
- Diferenca entre os tres cenarios (colonizacao, contaminacao, infeccao ativa) de forma integrada

Feedback: Diferenciou bem colonizacao e contaminacao com definicoes claras. Faltou enfatizar a necessidade de correlacao clinica para interpretar o achado e integrar os tres cenarios na decisao diagnostica.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- a) Caracterize morfolologicamente as leveduras.
- b) Defina micélio e relacione sua organização.
- c) Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

① OS FUNGOS SÃO CLASSIFICADOS COMO EUCARIÓTICOS HETEROTRÓFICOS POR POSSUIREM CÉLULAS COM NÚCLEO DEFINIDO E ORGANELAS COMPLEXAS, ALÉM DE NÃO PRODUIREM O PRÓPRIO ALIMENTO, DEPENDENDO DA ABSORÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA.

IMPACTO NA PATOGENICIDADE → ESSA COMPLEXIDADE CELULAR TORNA OS FUNGOS MAIS SEMELHANTES ÀS CÉLULAS HUMANAS DO QUE AS BACTÉRIAS. ISSO DIFICULTA O DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS (TOXICIDADE SELETIVA), POIS MUITOS ALVOS TERAPÊUTICOS NOS FUNGOS TAMBÉM ESTÃO PRESENTES NO HOSPEDEIRO HUMANO.

② O ERGOSTEROL É O PRINCIPAL ESTEROL DA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA DOS FUNGOS, RESPONSÁVEL POR MANTER A INTEGRIDADE, FLUIDEZ E FUNÇÃO DA MEMBRANA. ELE É ALVO PRINCIPAL DE CLASSES COMO OS POLIENOS (QUE SE LIGAM A ELE) E AZÓIS (QUE INIBEM SUA SÍNTESE). COMO AS CÉLULAS HUMANAS POSSUEM COLESTEROL EM VEZ DE ERGOSTEROL, ESSA DIFERENÇA PERMITE QUE OS MEDICAMENTOS ATAQUEM ESPECIFICAMENTE O FUNGO, MINIMIZANDO DANOS AO PACIENTE.

③ a) LEVEDURAS SÃO FUNGOS UNICELULARES, GERALMENTE OVAIS OU ESFÉRICOS, QUE SE REPRODUZEM POR BROTAMENTO (GEMULAÇÃO).

b) MICÉLIO É O CONJUNTO DE HIFAS (FILAMENTOS). SUA ORGANIZAÇÃO PERMITE A EXPLORAÇÃO DO SUBSTRATO, ABSORÇÃO DE NUTRIENTES E SECREÇÃO DE ENZIMAS, SENDO A BASE ESTRUTURAL DOS FUNGOS FILAMENTOSOS.

c) DIMORFISMO FÚNGICO É A CAPACIDADE DE ALGUNS FUNGOS CRESCEREM EM DUAS FORMAS, COMO LEVEDURA OU MOFO/FILAMENTO. ESSA MUDANÇA É UMA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO CRUCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA E INVASÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO HUMANO.

④ KOH É UM AGENTE CERATOLÍTICO: ELE DISSOLVE A QUERATINA E OUTROS RESTOS CELULARES NA AMOSTRA CLÍNICA. ISSO LIMPA O CAMPO VISUAL, PERMITINDO QUE AS ESTRUTURAS FÚNGICAS, QUE SÃO RESISTENTES À DIGESTÃO ALCALINA, FIQUEM VISÍVEIS AO MICROSCÓPIO PARA UM DIAGNÓSTICO RÁPIDO.

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

⑤ ELAS SE CARACTERIZAM POR NÃO INVADIR TECIDOS VIVOS E GERALMENTE NÃO PROVOCAREM UMA RESPOSTA IMUNOLÓGICA SIGNIFICATIVA DO HOSPEDEIRO SENDO O DANO PREDOMINANTEMENTE ESTÉTICO.

⑥ SUPERFICIAIS ACOMETEM APENAS A PARTE EXTERNA DA QUERATINA (PELE E PELOS), SEM DESENCADEAR RESPOSTA IMUNE. JÁ AS CUTÂNEAS ESTENDEM-SE MAIS PROFUNDAMENTE NA EPIDERMIS E PODEM AFETAR UNHAS E CABELOS. ELAS CAUSAM DESTRUIÇÃO DA QUERATINA E PROVOCAM REAÇÕES INFLAMATÓRIAS NO HOSPEDEIRO.

⑦ ELAS FAZEM PARTE DA MICROBIOTA NORMAL DO SER HUMANO. ELAS SÓ CAUSAM INFECÇÃO QUANDO ENCONTRAM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NO HOSPEDEIRO, COMO QUEDA DA IMUNIDADE, COMO DESEQUILÍBRIO DA FLORA BACTERIANA POR USO DE ANTIBIÓTICOS, ETC...

⑧ PODE REPRESENTAR APENAS COLONIZAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO.

A COLONIZAÇÃO É QUE O FUNGO ESTÁ PRESENTE E SE MULTIPLICANDO SEM CAUSAR DANO OU RESPOSTA CLÍNICA.

A CONTAMINAÇÃO É QUE O FUNGO FOI INTRODUZIDO NA AMOSTRA ACIDENTALMENTE DURANTE A COLETA OU PROCESSAMENTO LABORATORIAL.